

Fecha Última Actualización: 10-08-2024 8:35:47

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Noan Primitivo Valenzuela Toledo
Edad : 60a 4m 27d
Dirección : Servicio 726 V. Lomas Oriente

Rut : 9.910.525-9
Fecha Nacto: 14/03/1964
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1035711
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9915 8256

N° Epicrisis
409579

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 09/07/2024 16:19

Días Estadía: 32

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 10/08/2024 08:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea progresiva secundaria a masa en cuello / baja de peso marcada

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES:

DM2 NIR, Asma, RGE no especificado, Tno depresivo.

DIAGNÓSTICOS:

- ¿ Shock Séptico Refractario en estudio
- ¿ Obs Sdme Hemofagocítico / Linfoma
- ¿ Shock séptico, Obs foco respiratorio - FMO
- ¿ NAC ATS IV por Metapneumovirus
- ¿ VIH debut CD4 35 CV 784.000
- ¿ Infección sistémica por Citomegalovirus ¿ VEB
- ¿ Bicitopenia severa en estudio: anemia N-N + trombocitopenia
- ¿ AKI KDIGO III en HFAV (inicio 30/07/24)

EVOLUCION:

Paciente al momento cursando internación por Shock séptico a foco respiratorio x NEUMONIA Metapneumovirus / SAMR + infección generalizada por CMV en paciente de reciente diagnostico de VIH + Bicitopenia en estudio con alta sospecha de Sdme Hemo fagocítico / Linfoma (seguimiento Hematología) ¿ intercurriendo con SHOCK refractario + FMO (en progresión)

AL momento paciente de extrema gravedad bajo sedación SAS 1, ventilando en IOT/ARM VCV 35% - Pafi 260 con ultima TC TORAX (TAC con adenopatías infra y supradiafragmáticas con conglomerado mesentérico, esplenomegalia y nódulos pulmonares), hemodinamia inestable cursando SHOCK Refractario con requerimiento de Noradrenalina 0.3ug / Vasopresina 0.04 (en ascenso) con signos de mala perfusión distal, fallo renal en ascenso BUN 70 / Cr 1.49 / K 5.71 con signos de VEC aumentado (anasarca) ¿ cursando Acidosis metabólica persistente (aun con HCO3), fallo hepático grave con bilirrubinas elevadas BT 31.8 / BD 23.8 (ictericia generalizada), con hipoglicemias por lo que se ajusta el aporte con SG 30% BIC. hematológico Tricitopenia en estudio Plaquetopenia / Anemia / leucopenia (requerimiento de transfusiones) ¿ valorado por Hematología (realiza biopsia de medula se envía a citológico / bacteriológico) Infeccioso afebril con parámetros inflamatorios estacionarios PCR 53 /Ferritina 7749 / Fibrinógeno 62 ¿ cursando debut de VIH + infección x CMV + Neumonía x E. Coli en tratamiento con Ganciclovir + TMS.

Paciente con respuesta parcial al tratamiento, mayor requerimiento de DVA, progresión de FMO por lo que se comunica afiliares de gravedad de cuadro clínico ¿ pronostico ominoso y alto riesgo vital, acuden a acompañamiento.

EVOLUCION

Paciente con progresion de fallo multiorganico, refractario a tratamiento, mayor de requerimiento de DVA, intercorre con paro

Fecha Epicrisis : 10/08/2024 08:35

Página 1 de 2

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 10-08-2024 8:35:47

cardiaco - constatandose fallecimiento 06:32h - se comunica a familiares.

CAUSAS:

Arritmia ventricular compleja

Fallo multiorganico /Obs Sdme Hemofagocitico

Shock Septico

Debut de VIH

Diagnóstico de Egreso

Choque séptico - Debut B20 / Shock refractario / Fallo multiorganico

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

EVOLUCION

Paciente con progresion de fallo multiorganico, refractario a tratamiento, mayor de requerimiento de DVA, intercorre con paro cardiaco - constatandose fallecimiento 06:32h - se comunica a familiares.

CAUSAS:

Arritmia ventricular compleja

Fallo multiorganico /Obs Sdme Hemofagocitico

Shock Septico

Debut de VIH

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Juan Ulloa Mancero

Médico Tratante (Staff)